

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5079570-38.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

REQUERENTE: LUZIA FERNANDES FEIJO

REQUERIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

REQUERIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. SAÚDE. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL. FILA DO SUS. DEMORA EXCESSIVA CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IMINENTE RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL. ISONOMIA E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5079570-38.2024.4.02.5101

510015085852 .V4

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5079570-38.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

REQUERENTE: LUZIA FERNANDES FEIJO

REQUERIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

REQUERIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência interposto pela parte autora nos autos de origem em face do indeferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo Substituto da 23ª VF do Rio de Janeiro [evento 4, DESPADEC1, autos de origem], em que a demandante pretende ***cirurgia artroplastia total primária do quadril***, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de, não fazendo, ser determinado o sequestro ou bloqueio de suas verbas no montante necessário para custear o tratamento pleiteado na rede privada.

Já em sede recursal, aduz a recorrente que a ***probabilidade do direito*** estaria amparada nos documentos anexos à inicial, em que se comprova a existência da doença, a indispensabilidade dos insumos pleiteados, bem como a demora do Poder Público em prestar o devido atendimento.

Quanto ao ***risco ao resultado útil do processo*** seria evidenciada pelo risco de complicações imediatas e sequelas em longo prazo. Aduz que sem tratamento adequado para a patologia, a requerente, pessoa com idade avançada e diagnosticado com patologia considerada grave, havendo inclusive suspeita de neoplasia, poderá sofrer sérias complicações de saúde, agravando seu quadro clínico, podendo vir a óbito

Parecer técnico do NAT-Jus [evento 6, PARECER1] informando que a cirurgia pretendida está indicada para o quadro clínico da recorrente e é fornecida pelo SUS. Ademais, pontua que o Estado do Rio de Janeiro conta com as unidades habilitadas no SUS para atenção ortopédica e suas referências para as ações em ortopedia de média e alta complexidade.

Ainda, foi informado pelo NAT-Jus que a recorrente solicitou consulta em 24/10/2022, com atendimento confirmado em 08/12/2022, com a seguinte observação: “Atendido / Mandado associado - Data: 27/09/2024 Nº processo: 5073303-50.2024.4.02.5101”.

Indeferida a tutela recursal [evento 13, DESPADEC1].

Contrarrazões [evento 21, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que indeferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"Antes de adentrar a análise da tutela recursal pretendida, cumpre esclarecer que esta relatora determinou a intimação da recorrente para prestar esclarecimentos quanto à obtenção administrativa da cirurgia aqui pretendida, à luz da informação prestada pelo NAT-Jus, apontando movimentação do caso em 27/09/2024.

Em resposta, a DPU se manifesta informando não ter conseguido contato com a assistida e solicitando a sua intimação pessoal [evento 11, PET1]. Todavia, compulsando os autos de origem, especialmente os documentos acostados pelas rés em contestação, entendo desnecessária a intimação pessoal da demandante.

Isto porque o Município do Rio de Janeiro, em sintonia com as informações prestadas pelo NAT-Jus, informa em 01/10/2024 que a demandante, ora recorrente, está em lista de espera para a cirurgia desde 16/02/2023 e que ainda não foi submetida ao atendimento porque atualmente o Hospital Federal dos Servidores do Estado não possui material necessário [evento 23, OFIC2, fl. 4, autos de origem].

Portanto, como se nota, a recorrente ainda não obteve administrativamente o procedimento cirúrgico pelo qual postula em sede judicial, de modo que permanece existindo o interesse de agir.

*Vale lembrar que a demandante obteve diagnóstico de **coxartrose (CID 10: M16.9)**, com algia em ambas as articulações coxo femorais, sobretudo em articulação esquerda, apresenta dificuldade de deambulação e limitação de amplitude dos movimentos. Há, ainda, suspeita de neoplasia, que, todavia, não pode ser confirmada por biópsia porque a recorrente sente fortes dores ao abrir as pernas.*

As informações acima foram detalhadas em laudo médico firmado em 9 de setembro de 2024 [evento 1, ANEXO2, fls. 14/16, autos de origem], que, todavia, não discorre a respeito dos iminentes riscos atrelados à demora do procedimento cirúrgico.

Pois bem. Primeiramente, o Enunciado nº 93 da III Jornada de Saúde do CNJ firmou o entendimento segundo o qual considera excessiva a demora no acesso à serviços de saúde nas seguintes hipóteses:

*"Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo **superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.**"*

Na espécie, consta informação de que a recorrente aguarda em fila de espera desde 16/02/2023 [evento 23, OFIC2, fl. 4, autos de origem], mais de um ano. Portanto, configurada a demora excessiva.

A despeito da ampla documentação confirmatória da indicação do tratamento e da caracterização da demora excessiva na prestação do serviço pelo SUS, não vislumbro violação de direitos fundamentais, nem conduta ilegal ou abusiva do Poder Público que justifique a atuação do Poder Judiciário.

*Ademais, **não há nos autos comprovação de iminente risco de dano irreversível** que justifique, excepcionalmente, a quebra do procedimento organizacional adotado na esfera administrativa. Reforço, neste sentido, que apesar de a recorrente falar em risco de óbito, não há laudo médico que dê subsídio à afirmação.*

Isto posto, entendo que a causa exige autocontenção pelo Poder Judiciário, conforme jurisprudência a seguir colacionada, que vê na fila do SUS critério objetivo de isonomia para casos análogos:

AGRAVO INTERNO. LIMINAR. CIRURGIA. FILA. ORDEM DE INSCRICAO. OBEDIENCIA. ISONOMIA. 1. A despeito da generosa interpretação dada ao art. 196 da Constituição por alguns arestos, certo é que o Estado não tem condições de assegurar, a todos e de pronto, 'o acesso ao tratamento necessário a cura de suas doenças', principalmente nos poucos hospitais públicos de referencia existentes no País. 2. **Sem demonstração de ilegitimidade da fila e, pois, da ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXIX, CF), qualquer decisão judicial que determine cirurgia imediata caracterizaria injustificada vantagem pessoal a vista da situação comum em que se encontram os vários pacientes na fila, eis que "descabe ao Judiciário estabelecer prioridades de natureza medica.** Este não é administrador do SUS e, caso se admitisse a sua intervenção indevida, teria também que resolver os problemas decorrentes de sua atuação, haja vista que se uma pessoa realiza o exame por força de tutela

judicial, outra, que teria direito por ordem natural, seria prejudicada" (cf. TRF2, 7a Turma Esp., AI no 2010.02.01.017554-5, Rel. Des. Fed. Jose Antonio Lisboa Neiva). 3. Assim, embora lamentando profundamente a situação, não cabe ao Judiciário quebrar a isonomia. 4. Agravo interno desprovido

(TRF-2, AI 217227, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, j. 10/10/2012).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO À SAÚDE. ART. 196, CF. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. **ISONOMIA. RESPEITO À FILA ADMINISTRATIVAMENTE ORGANIZADA.** 1. O direito à saúde implica para o Poder Público o dever inescusável de adotar providências necessárias e indispensáveis para a sua promoção, estabelecidas de forma universal e igualitária. Nesse contexto jurídico, se o Poder Público negligencia no atendimento de seu dever, cumpre ao Poder Judiciário intervir, num verdadeiro controle judicial de política pública, para conferir efetividade ao correspondente preceito constitucional. 2. **Todavia, o acesso ao referido direito deve ser compatibilizado com o princípio da isonomia, de forma a não garantir privilégios àqueles que procuram o Judiciário em detrimento dos que aguardam por tratamentos e cirurgias de acordo com a fila administrativamente estabelecida. Assim, não cabe ao Judiciário administrar hospitais, estabelecendo prioridades de natureza médica. Precedentes.** 3. Dessa forma, cabe à Administração Pública, mediante exame com base em critérios técnicos, aferir a possibilidade de internação no INCA ou em qualquer outro hospital da rede pública, respeitando a fila administrativamente estabelecida. 4. Por outro lado, é inviável, em um quadro insatisfatório, socializar o custeio de internação em rede hospitalar privada. Do mais, o deferimento do pedido, nesta hipótese, também representaria verdadeira preterição aos pacientes que aguardam na fila de espera. 5. Embargos infringentes conhecidos e providos.

(EAC 201151014901233 Desembargador Federal JOSE ANTONIO LISBOA NEIVA TERCEIRA SEÇÃO ESPECIALIZADA -DJF2R - Data::02/10/2012 - Página::28/29)

Por todo o exposto, entendo ausentes o requisito do risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Federais, e **INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL.**"

Registre-se que desde a prolação da decisão referenciada, não foram apresentados novos fatos ou argumentos com vistas à sua revisão.

Logo, merece confirmação a decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal e, no mérito, merece desprovimento o recurso.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.